HSC | GLOBAL



AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 3

Literatura científica e pesquisa de evidências clínicas

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 3

MÓDULO	3 de 5, ao vivo
DOCUMENTO BASE	MEDDEV 2.7/1 Rev. 4; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XIV
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência das aulas do Módulo 3, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia a qualidade da evidência clínica.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

• Mapa do módulo: aula, apostila e caderno 3

1 Fontes de dados clínicos 4

2 O fluxo PRISMA na avaliação clínica 7

3 Critérios de elegibilidade definidos antes da busca 10

4 A pergunta clínica no formato PICO 13

5 Da pergunta à estratégia de busca 16

6 Tabela de evidência e risco de viés 19

7 Caso integrador GlucoSense 22

8 Glossário 25

9 Para revisar 26

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 3 é ao vivo e tem cinco blocos, das fontes de dados clínicos até um caso integrador.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	Fontes de dados clínicos	Slides 2 a 6	Capítulo 1	Pergunta 1
2	Fluxo PRISMA e critérios de elegibilidade	Slides 7 a 13	Capítulos 2 e 3	Perguntas 2 e 3
3	Pergunta PICO e estratégia de busca	Slides 14 a 20	Capítulos 4 e 5	Perguntas 4 e 5
4	Tabela de evidência e risco de viés	Slides 21 a 24	Capítulo 6	Perguntas 6 e 7
5	Caso integrador GlucoSense	Slides 25 a 31	Capítulo 7	Pergunta 8

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco com o MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 aberto no anexo citado.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote como cada etapa da busca deixa rastro e quais sinais de alerta o professor aponta.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda a pergunta de revisão do capítulo e registre suas dúvidas na página de anotações.

ANTES DO MÓDULO 4

O Módulo 4 trata dos dados pós-mercado, da análise de benefício e risco e da atualização da avaliação clínica. Revise os capítulos 1 e 6: as fontes de dados e a avaliação crítica voltam lá.

CAPÍTULO 1

Fontes de dados clínicos

NA AULA **Bloco 1 • slides 2 a 6** Para revisar • Pergunta 1

Observe como cada fonte de dado responde a uma pergunta diferente sobre o dispositivo.

Antes de discutir busca e seleção de estudos, você precisa saber de onde vêm os dados que sustentam uma avaliação clínica. O avaliador começa por aqui: a avaliação considerou tudo o que existe, ou só o que convinha?

O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 pede que a avaliação clínica use todos os dados clínicos disponíveis e relevantes sobre o dispositivo e, quando for o caso, sobre um dispositivo equivalente. Relevante quer dizer ligado ao uso pretendido, à população e às alegações de segurança e desempenho. Disponível quer dizer que o fabricante procurou de forma ativa, inclusive o que é desfavorável.

Quatro origens possíveis

- **Investigação clínica do próprio dispositivo.** É a fonte mais direta, porque protocolo, população e desfechos foram definidos para aquele produto. Quando conduzida conforme a ISO 14155:2026, o avaliador consegue rastrear como cada dado foi gerado.
- **Literatura científica publicada.** Estudos revisados por pares sobre o dispositivo ou sobre dispositivos equivalentes. O valor depende do desenho do estudo e de quanto ele se aplica ao produto avaliado.
- **Dados pós-mercado.** Acompanhamento clínico pós-mercado, registros clínicos, estudos observacionais e vigilância. Mostram o comportamento no uso real e ajudam a encontrar eventos raros ou tardios.
- **Dados de dispositivo equivalente.** Só entram quando a equivalência técnica, biológica e clínica está demonstrada e justificada, ponto a ponto.

O AVALIADOR PERGUNTA

A busca foi ativa?

Existe registro de onde e como os dados foram procurados, com datas e critérios.

O AVALIADOR PERGUNTA

Os dados se aplicam?

População, indicação e versão do dispositivo conferem com o que está sendo avaliado.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Fontes de dados clínicos

Peso e limites de cada fonte

Nenhuma fonte resolve tudo sozinha. A investigação própria responde às alegações do dispositivo, mas costuma ter amostra e seguimento limitados. A literatura amplia o volume de dados, mas exige demonstrar que os estudos se aplicam ao produto. Os dados pós-mercado trazem o uso real, porém com menos controle sobre como foram coletados. Por isso o avaliador olha o conjunto: as fontes se complementam e cobrem as lacunas umas das outras, ou deixam alegações sem nenhum dado por trás?

Quando o fabricante usa dados de outro dispositivo, a pergunta muda de foco. Antes de avaliar o que os estudos dizem, é preciso aceitar que eles falam de um produto equivalente. Sem essa demonstração, os dados podem ser bons e ainda assim não servir.

ERRO COMUM

Tratar a ausência de relatos negativos como prova de segurança. Se a busca não foi desenhada para encontrar eventos adversos, ela não serve para afirmar que eles não existem.

IDEIA-CHAVE

A pergunta não é quantos estudos existem, e sim se o conjunto de dados cobre todas as alegações do dispositivo.

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, seção 8; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XIV, Parte A.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Fontes de dados clínicos

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

O fluxo PRISMA na avaliação clínica

NA AULA **Bloco 2 • slides 7 a 10** **Para revisar • Pergunta 2**

Observe como cada número do diagrama de fluxo precisa ter origem rastreável.

O diagrama de fluxo PRISMA mostra o caminho entre tudo o que a busca encontrou e os estudos que de fato entraram na análise. Para o avaliador, é a prova de que a seleção seguiu método e não preferência.

O PRISMA nasceu como diretriz de relato de revisões sistemáticas. Na avaliação clínica de dispositivos, o mesmo diagrama ganha uma função a mais: demonstrar que a busca foi exaustiva e que qualquer pessoa conseguiria repeti-la e chegar ao mesmo resultado. O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 espera que o protocolo de busca e o resultado da seleção estejam documentados no relatório.

As etapas do fluxo

ETAPA	O QUE O DIAGRAMA REGISTRA
Identificação	Registros encontrados em cada base e duplicatas removidas
Triagem	Títulos e resumos avaliados e excluídos, com o motivo
Elegibilidade	Textos completos lidos e excluídos, com o motivo de cada um
Inclusão	Estudos que entram na análise, por tipo de desenho

A versão de 2009 do PRISMA separava a elegibilidade como etapa própria. A versão de 2020 agrupa o fluxo em identificação, triagem e inclusão, com a leitura do texto completo dentro da triagem. Para quem avalia, a versão importa menos do que a coerência: os números de uma etapa precisam fechar com os da etapa seguinte.

Uso acadêmico e uso regulatório

Numa revisão acadêmica, o objetivo é sintetizar a evidência sobre uma pergunta clínica, muitas vezes com metanálise. Na avaliação clínica, o diagrama também precisa mostrar quais estudos pesam mais, por exemplo os conduzidos conforme a ISO 14155, e sustentar a análise de benefício e risco do dispositivo.

Na prática, o avaliador lê o diagrama junto com o protocolo de busca. Se o protocolo previa quatro bases e o diagrama mostra registros de duas, há uma lacuna a explicar. Se o diagrama informa um número de estudos incluídos diferente do que aparece na tabela de evidência, a divergência precisa ser resolvida antes de qualquer conclusão.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

O fluxo PRISMA na avaliação clínica

SINAL DE ALERTA

Totais que não batem entre etapas, exclusões sem motivo ou motivos genéricos como "não relevante" indicam que a seleção não pode ser reproduzida.

IDEIA-CHAVE

O diagrama PRISMA é uma trilha de auditoria da seleção: cada número precisa ter de onde veio.

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexo A5; PRISMA Statement (2009 e 2020).

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O fluxo PRISMA na avaliação clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Critérios de elegibilidade definidos antes da busca

NA AULA **Bloco 2 • slides 11 a 13** Para revisar • Pergunta 3

Observe por que o momento em que os critérios são definidos muda a confiança no resultado.

Critérios de inclusão e exclusão decidem quais estudos entram na avaliação. Se forem escolhidos depois de ver os resultados, qualquer conclusão fica sob suspeita.

Por isso os critérios precisam ser definidos a priori, no protocolo de busca, antes de qualquer triagem. Eles derivam da pergunta clínica: quem é a população, qual é o dispositivo ou o equivalente, qual é o comparador e quais desfechos interessam. O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 trata o protocolo de busca como parte da documentação que o avaliador examina.

INCLUSÃO

O estudo entra se atende a todos

População compatível, dispositivo ou equivalente demonstrado, comparador adequado, desfechos de segurança e desempenho, desenho e período justificados.

EXCLUSÃO

O estudo sai se atende a qualquer um

População não representativa, dispositivo não equivalente, estudo só in vitro ou em animal, resumo sem dados suficientes, publicação duplicada da mesma coorte.

O que o avaliador confere

- Se a data do protocolo é anterior à execução da busca.
- Se cada critério é específico e mensurável, e não uma intenção vaga.
- Se restrições de idioma, período ou tipo de publicação têm justificativa. Cada restrição reduz o universo e pode introduzir viés.
- Se a mesma coorte publicada mais de uma vez foi contada uma única vez.
- Se os motivos de exclusão no diagrama correspondem aos critérios escritos.

Por que restrições pedem justificativa

Limitar a busca a um idioma ou a um período curto pode parecer apenas uma decisão prática, mas muda o conjunto de estudos encontrados. Um período curto pode deixar de fora os estudos com seguimento longo, justamente os que mostram eventos tardios. Um único idioma pode excluir dados de populações relevantes para o uso pretendido. A justificativa precisa explicar por que a restrição não compromete a resposta à pergunta clínica.

Os critérios também precisam tratar dos estudos que não podem ser avaliados: resumos de congresso sem dados completos, por exemplo, raramente permitem uma análise crítica e costumam ser excluídos com esse motivo registrado.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Critérios de elegibilidade definidos antes da busca

PERGUNTA ÚTIL

Algum estudo desfavorável foi excluído por um critério que não aparece no protocolo? Se sim, a exclusão não se sustenta.

IDEIA-CHAVE

Critério definido depois da busca não é critério, é escolha. A objetividade da seleção começa no protocolo.

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexo A5.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Critérios de elegibilidade definidos antes da busca

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

A pergunta clínica no formato PICO

NA AULA **Bloco 3 • slides 14 a 18** Para revisar • Pergunta 4

Observe como cada letra do PICO se transforma em termo de busca e em critério de elegibilidade.

Uma busca de literatura só é boa se a pergunta for boa. O formato PICO organiza a pergunta clínica em quatro partes e torna visível o que a busca precisa encontrar.

LETRA	COMPONENTE	O QUE PRECISA ESTAR CLARO
P	População	Idade, condição clínica, gravidade, tratamentos anteriores e condições que excluem o paciente
I	Intervenção	O dispositivo ou procedimento: modelo, materiais, mecanismo de ação e técnica de uso
C	Comparação	O controle: tratamento padrão, outro dispositivo ou nenhum
O	Desfechos	Desfechos de segurança e de desempenho clinicamente relevantes, com o tempo de seguimento

O PICO liga três coisas que o avaliador quer ver alinhadas: a pergunta, a busca e a interpretação. Se a pergunta fala de adultos e os estudos incluídos são pediátricos, a conclusão não se aplica. Se a intervenção é descrita de forma genérica, a busca traz dispositivos que não são comparáveis.

Um exemplo para treinar o olhar

Imagine um stent coronariano fictício com eluição de fármaco. A população seriam adultos com doença arterial coronariana elegíveis para intervenção percutânea. A intervenção, o stent com sua plataforma, fármaco e polímero. A comparação, stents farmacológicos já estabelecidos. Os desfechos, revascularização da lesão-alvo, trombose de stent e eventos cardíacos maiores no seguimento.

O que o avaliador procura

Ao revisar uma avaliação clínica, você deve encontrar a pergunta PICO escrita de forma explícita, antes da descrição da busca. Em seguida, confira se os termos de busca cobrem cada componente e se os critérios de inclusão repetem a mesma população, a mesma intervenção e os mesmos desfechos. Quando os desfechos escolhidos são apenas substitutos, como uma medida laboratorial, verifique se a relação com o benefício clínico está justificada.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

A pergunta clínica no formato PICO

Uma pergunta mal formulada costuma aparecer de duas formas: ampla demais, trazendo milhares de registros sem relação com o dispositivo, ou estreita demais, deixando de fora estudos de que a avaliação precisaria.

DETALHE QUE PESA

Quanto mais precisa a descrição da intervenção, mais fácil decidir se um estudo publicado trata de um dispositivo equivalente ou de outro produto.

IDEIA-CHAVE

O PICO é o contrato da busca: tudo o que entra ou sai da avaliação precisa caber nele.

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexo A5; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XIV, Parte A.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

A pergunta clínica no formato PICO

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Da pergunta à estratégia de busca

NA AULA **Bloco 3 • slides 19 a 20** Para revisar • Pergunta 5

Observe o que torna uma busca reprodutível por outra pessoa.

A estratégia de busca traduz o PICO para a linguagem de cada base de dados. Para o avaliador, ela só tem valor se for exaustiva e reprodutível.

Exaustiva significa que a combinação de bases e termos tem chance real de encontrar todos os estudos relevantes. Reprodutível significa que outra pessoa, com o registro em mãos, repete a busca e obtém o mesmo conjunto de registros na mesma data.

Elementos que o registro precisa mostrar

- **Bases consultadas.** Por exemplo, PubMed/MEDLINE, Embase, Cochrane Library e registros de estudos como o ClinicalTrials.gov, que ajuda a localizar estudos não publicados.
- **Termos controlados e livres.** Descritores do vocabulário de cada base, como o MeSH no PubMed, somados a sinônimos, siglas e nomes comerciais.
- **Lógica de combinação.** Operadores que unem sinônimos dentro de um conceito e cruzam os conceitos do PICO entre si.
- **Filtros e limites.** Desenho, período e idioma, cada um justificado.
- **Data e expressão exata** de cada execução, base por base.

A triagem também é método

A seleção de títulos, resumos e textos completos é feita, de preferência, por dois revisores independentes, com os desacordos resolvidos e registrados. Ferramentas de apoio à triagem ajudam a organizar o trabalho, mas não substituem o registro das decisões.

Bases diferentes, coberturas diferentes

Cada base indexa um conjunto diferente de periódicos e usa um vocabulário próprio. Uma estratégia montada para o PubMed não funciona igual no Embase sem adaptação de descritores. Por isso o registro precisa mostrar a expressão usada em cada base, e não apenas uma expressão genérica. Registros de estudos e literatura regional, como a latino-americana, completam o quadro e reduzem o risco de viés de publicação, quando só os resultados positivos chegam aos periódicos.

Quando a busca é atualizada para uma nova versão da avaliação clínica, a mesma lógica vale: a nova execução precisa ser registrada com sua data e comparável à anterior.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Da pergunta à estratégia de busca

SINAL DE ALERTA

Uma única base, sem data de execução e sem a expressão de busca completa, impede qualquer verificação. O avaliador não tem como saber o que ficou de fora.

IDEIA-CHAVE

Busca que não pode ser repetida não pode ser verificada, e o que não pode ser verificado não sustenta a avaliação clínica.

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexo A5; PRISMA Statement.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Da pergunta à estratégia de busca

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Tabela de evidência e risco de viés

NA AULA **Bloco 4 • slides 21 a 24** **Para revisar • Perguntas 6 e 7**

Observe como a qualidade de cada estudo muda o peso que ele tem na conclusão.

Depois da seleção, cada estudo incluído precisa ser descrito e avaliado da mesma forma. A tabela de evidência é o lugar onde o avaliador compara os estudos lado a lado.

O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 trata essa etapa como avaliação dos dados: cada conjunto é examinado quanto à qualidade metodológica, à relevância para o dispositivo e à contribuição para as alegações de segurança e desempenho.

GRUPO DE INFORMAÇÃO	EXEMPLOS DO QUE REGISTRAR
Identificação	Referência completa, desenho do estudo, nível de evidência, registro do estudo e financiamento
Conteúdo	População, dispositivo, comparador, desfechos com medidas de precisão, eventos adversos
Qualidade	Seguimento e perdas, conformidade com a ISO 14155, risco de viés, limitações e aplicabilidade

Risco de viés em ensaios randomizados

Para ensaios randomizados, a ferramenta RoB 2, da Cochrane, organiza a avaliação em cinco domínios:

- processo de randomização, que verifica se os grupos ficaram comparáveis;
- desvios da intervenção pretendida;
- dados de desfecho ausentes;
- mensuração do desfecho;
- seleção do resultado relatado.

Estudos observacionais pedem ferramentas próprias, mas a lógica é a mesma: identificar o que pode ter distorcido o resultado.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Tabela de evidência e risco de viés

Da tabela à conclusão

A tabela de evidência não é um fim em si. Ela alimenta a análise do conjunto: quais estudos sustentam cada alegação, com que consistência e com que limitações. O avaliador verifica se a conclusão do relatório reflete o que a tabela mostra. Se os estudos de melhor qualidade apontam um resultado e a conclusão se apoia nos de menor qualidade, há uma incoerência a apontar.

Outro ponto é o financiamento. Estudos financiados pelo fabricante não são inválidos, mas a informação precisa estar registrada para que o leitor pondere possíveis conflitos de interesse.

O QUE O AVALIADOR VERIFICA

Se a mesma régua foi aplicada a todos os estudos, inclusive aos favoráveis, e se estudos com alto risco de viés receberam menos peso na conclusão.

IDEIA-CHAVE

Nem todo estudo pesa igual. A tabela de evidência mostra por que cada um pesa o que pesa.

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, seção 9 e Anexo A6; RoB 2 (Cochrane).

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Tabela de evidência e risco de viés

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Caso integrador GlucoSense

NA AULA **Bloco 5 • slides 25 a 31** Para revisar • Pergunta 8

Observe como o caso percorre, em sequência, tudo o que foi visto nos blocos anteriores.

O caso GlucoSense é fictício e serve para juntar as peças do módulo. Uma startup brasileira desenvolve um sistema de monitoramento contínuo de glicose, com sensor subcutâneo e alarmes de hipoglicemia, e prepara a regularização na Anvisa e em outros mercados.

O ponto de partida: a pergunta

PICO	NO CASO
População	Adultos com diabetes tipo 1 e controle glicêmico inadequado
Intervenção	Monitoramento contínuo de glicose em tempo real, com alarmes
Comparação	Glicemia capilar tradicional
Desfechos	Hemoglobina glicada, tempo na faixa-alvo, hipoglicemias graves, qualidade de vida

Da busca à triagem

No caso, a busca percorre várias bases e um registro de estudos, combina descritores e texto livre e registra a data de execução. Os registros encontrados passam pela remoção de duplicatas e seguem para a triagem de títulos e resumos. Em aula, você acompanha os números de cada etapa e pode conferir se eles fecham entre si.

AO LER O CASO

Confira a coerência

Os critérios de elegibilidade derivam do PICO? Os motivos de exclusão aparecem no protocolo?

AO LER O CASO

Confira a aplicabilidade

Os dispositivos encontrados são de fato equivalentes ao sistema avaliado, em técnica, biologia e uso clínico?

Depois da triagem

O caso continua com a leitura dos textos completos, a extração dos dados para a tabela de evidência e a avaliação do risco de viés de cada estudo incluído. Em cada etapa, pergunte o que o avaliador encontraria se abrisse o registro: os motivos de exclusão estão escritos, os estudos incluídos usam um dispositivo equivalente demonstrado, os desfechos correspondem ao PICO?

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Caso integrador GlucoSense

O caso também mostra a diferença entre fazer uma busca e demonstrar uma busca. A empresa pode ter encontrado os estudos certos, mas, sem registro, o avaliador não tem como saber.

LEITURA CRÍTICA

Um conjunto grande de registros não garante evidência suficiente. O que importa é quantos estudos chegam à inclusão, com qual desenho e com qual risco de viés.

IDEIA-CHAVE

Pergunta, busca, seleção e avaliação crítica formam uma cadeia. Se um elo falha, a conclusão da avaliação clínica fica sem sustentação.

Fonte: caso fictício elaborado para fins didáticos; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexos A5 e A6.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Caso integrador GlucoSense

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Avaliação clínica

Processo contínuo de coleta, avaliação e análise dos dados clínicos de um dispositivo para verificar segurança e desempenho.

Dado clínico

Informação sobre segurança ou desempenho gerada pelo uso do dispositivo em pessoas.

Dispositivo equivalente

Dispositivo com equivalência técnica, biológica e clínica demonstrada em relação ao avaliado.

PMCF

Acompanhamento clínico pós-mercado: coleta proativa de dados clínicos depois da colocação no mercado.

Revisão sistemática

Revisão da literatura com pergunta definida, busca e seleção por método explícito e reprodutível.

PRISMA

Diretriz de relato de revisões sistemáticas, com um diagrama de fluxo da seleção de estudos.

Critérios de elegibilidade

Regras de inclusão e exclusão de estudos, definidas antes da busca.

PICO

Estrutura da pergunta clínica: população, intervenção, comparação e desfechos.

MeSH

Vocabulário controlado de descritores usado para indexar a literatura no PubMed.

Protocolo de busca

Documento que define bases, termos, combinações, filtros e critérios antes da execução.

Tabela de evidência

Quadro que descreve e compara os estudos incluídos com os mesmos campos.

Risco de viés

Possibilidade de que falhas de desenho ou condução distorçam o resultado de um estudo.

RoB 2

Ferramenta da Cochrane para avaliar o risco de viés em ensaios randomizados, em cinco domínios.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que a ausência de relatos de eventos adversos na literatura não prova que o dispositivo é seguro? *(Cap. 1)*

2. Que inconsistência no diagrama de fluxo faria você duvidar da seleção de estudos? *(Cap. 2)*

3. O que muda na confiança da avaliação quando os critérios de elegibilidade são definidos depois da busca? *(Cap. 3)*

4. Como uma descrição vaga da intervenção no PICO afeta a decisão sobre equivalência? *(Cap. 4)*

5. Que informações você precisaria para repetir uma busca de literatura e chegar ao mesmo resultado? *(Cap. 5)*

6. Por que dois estudos com o mesmo resultado podem ter pesos diferentes na conclusão? *(Cap. 6)*

CAPÍTULO 9 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

7. Em qual domínio do RoB 2 um estudo sem cegamento do avaliador do desfecho perde confiança, e por quê? *(Cap. 6)*

8. No caso GlucoSense, que elo da cadeia você verificaria primeiro, e por quê? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com